

CAPÍTULO 6.7

Hipoglucemiantes Orales

PERFIL EUNACOM 1.04.1.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hipoglucemiantes Orales (HGO)

Solo útiles en **DM tipo 2** (y MODY). No sirven en DM1, LADA ni DM autoinmune.

Clasificación

Clásicos

TABLA 6.7.1: FÁRMACO VS MECANISMO			
FÁRMACO	MECANISMO	RIESGO HIPOGLICEMIA	CARACTERÍSTICA CLAVE
Metformina	↓ resistencia a insulina	No	Primera línea. Barata, eficaz, segura. RAM: GI.
Glibenclamida	↑ secreción pancreática insulina	Sí	Barata. Segunda línea si no hay recursos. Sube peso.
Tiazolidinedionas (pioglitazona)	↓ resistencia a insulina	No	↑ riesgo CV / IC. En desuso.
Acarbosa	Inhibe alfa glucosidasa	No	Poco eficaz. No se usa.
Meglitinidas (repaglinida)	↑ secreción insulina	Moderado	Similar a sulfonilúreas.

Nuevos

TABLA 6.7.2: FAMILIA VS EJEMPLO				
FAMILIA	EJEMPLO	MECANISMO	VENTAJA	CUÁNDO USAR DE ELECCIÓN
iDPP4 (gliptinas)	Sitagliptina	↑ GLP1 → ↑ insulina	Bajo riesgo hipo	Segunda línea estándar (MINSAL)
Agonistas GLP1 (glutidos)	Liraglutida, semaglutida	↑ insulina + ↓ glucagón	Bajo riesgo hipo; cardioprotector	IRC con albuminuria, ECV establecida
iSGLT2 (gliflozinas)	Empagliflozina	Glucosuria renal	IC, nefroprotector	Insuficiencia Cardíaca: Generalidades

Contraindicaciones por patología

TABLA 6.7.3: COMORBILIDAD VS CONTRAINDICADO			
COMORBILIDAD	CONTRAINDICADO	DE ELECCIÓN	
Insuficiencia renal (CICr < 30)	Metformina	GLP1, insulina	
Insuficiencia Cardíaca: Tratamiento	Insuficiencia cardíaca	Metformina, glibenclamida	iSGLT2 (empagliflozina)
IRC + macroalbuminuria	Metformina	GLP1 o iSGLT2	

| ECV establecida | — | GLP1 o iSGLT2 |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 62 años con DM2 y antecedentes de insuficiencia cardíaca con FEVI 38% consulta por mal control glicémico (HbA1c 8.4%) bajo Metformina."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

En DM2 con Insuficiencia Cardíaca (o ERC con albuminuria), los inhibidores de SGLT2 (Dapagliflozina, Empagliflozina) son el fármaco de elección de segunda línea por su beneficio demostrado en reducción de hospitalizaciones por IC y progresión renal.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Metformina es siempre primera línea en DM2: reduce producción hepática de glucosa, no causa hipoglicemia, neutra en peso.
- Metformina contraindicada con VFG <30 ml/min por riesgo de acidosis láctica. Suspender 48h antes de contraste yodado.
- Sulfonilureas (glibenclamida, glimepirida) son secretagogos: causan hipoglicemia y aumento de peso. Peligrosas en adultos mayores.
- Inhibidores de SGLT-2 (empagliflozina, dapagliflozina): glucosuria, baja de peso, beneficio CV y renal. EA: infecciones genitourinarias, cetoacidosis euglicémica.
- Agonistas GLP-1 (semaglutida, liraglutida): subcutáneos, baja de peso, beneficio CV. EA: náuseas, pancreatitis.
- Inhibidores DPP-4 (sitagliptina): bien tolerados, neutros en peso, sin beneficio CV.
- Pioglitazona: retención de líquidos, contraindicada en ICC.
- Segunda línea en paciente con ECV, ICC o ERC: preferir iSGLT-2 o aGLP-1.

EUNACOM CRITERIOS

Metformina es primera línea siempre. Solo se omite si: IRC (CICr < 30) o IC severa. **Glibenclamida: contraindicada en hipoglicémicos o > 75 años.**

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPOGLUCEMIANTES ORALES)

PREGUNTA 1

Paciente de 55 años, diabético tipo 2 en tratamiento con metformina 2 gramos al día, HbA1c 8.5%. Tiene antecedente de infarto agudo al miocardio hace 2 años. ¿Cuál es el mejor fármaco para agregar como segunda línea?

- A) Glibenclamida
- B) Pioglitazona
- C) Empagliflozina
- D) Sitagliptina
- E) Insulina NPH

PREGUNTA 2

Paciente diabético tipo 2 tratado con metformina y un nuevo fármaco agregado hace 3 meses consulta por infecciones urinarias recurrentes y candidiasis genital. ¿Cuál es el fármaco más probablemente responsable?

- A) Glimepirida
- B) Sitagliptina
- C) Pioglitazona
- D) Dapagliflozina
- E) Liraglutida

PREGUNTA 3

Paciente de 70 años, diabético tipo 2 con creatinina de 3.2 mg/dL y VFG estimada de 18 ml/min. ¿Cuál de los siguientes hipoglucemiantes está contraindicado?

- A) Insulina glargina
- B) Metformina
- C) Sitagliptina
- D) Liraglutida
- E) Pioglitazona

RESUMEN: HIPOGLUCEMIANTES ORALES

Los hipoglucemiantes orales son los fármacos fundamentales en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. La metformina es siempre el fármaco de primera línea: es una biguanida que reduce la producción hepática de glucosa y mejora la sensibilidad periférica a la insulina, sin causar hipoglicemia por sí sola y siendo neutra o levemente reductora de peso. Su principal contraindicación es la insuficiencia renal severa con VFG menor a 30 ml/min por riesgo de acidosis láctica, y debe suspenderse 48 horas antes del uso de medio de contraste yodado. Las sulfonilureas (glibenclamida, glimepirida) son secretagogos que estimulan directamente la liberación de insulina desde las células beta, independiente de los niveles de glucosa. Su principal efecto adverso es la hipoglicemia, especialmente peligrosa en adultos mayores y pacientes con función renal disminuida. Los inhibidores de SGLT-2 (empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina) bloquean la reabsorción renal de glucosa generando glucosuria, con beneficio cardiovascular y renal demostrado. Los agonistas de GLP-1 (semaglutida, liraglutida) estimulan la secreción de insulina de forma glucosa-dependiente, reducen peso significativamente y tienen beneficio cardiovascular. Los inhibidores de DPP-4 (sitagliptina, vildagliptina) son bien tolerados, neutros en peso y con bajo riesgo de hipoglicemia. La regla clave para el EUNACOM es que la primera línea siempre es metformina, y la segunda línea depende del contexto clínico: si hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, se prefieren inhibidores de SGLT-2 o agonistas de GLP-1 por su beneficio demostrado en estos escenarios.